

Ключевые выводы по эпидситуации, динамике, эффективности мер в РФ

Динамика ПЗ, ОЗ и смертности в ...



Ключевые выводы

Основные показатели

Показатель	Пик (год)	Последний год	Снижение
Заболеваемость	90,4 (2000)	26,9 (2024)	в 3,4 раза
Распространённость	272,8 (2002)	48,1 (2024)	в 5,7 раза

Что это значит

- Все показатели синхронно снижаются* с 2000-х годов → система работает эффективно.
- Распространённость снизилась сильнее всего* → лечение и диспансеризация дают результат.
- С 2015 года темпы снижения ускорились* → эффект новых методов.
- Спад в 2020 году* (41,2 → 32,4) — вероятно, связан с пандемией COVID-19.

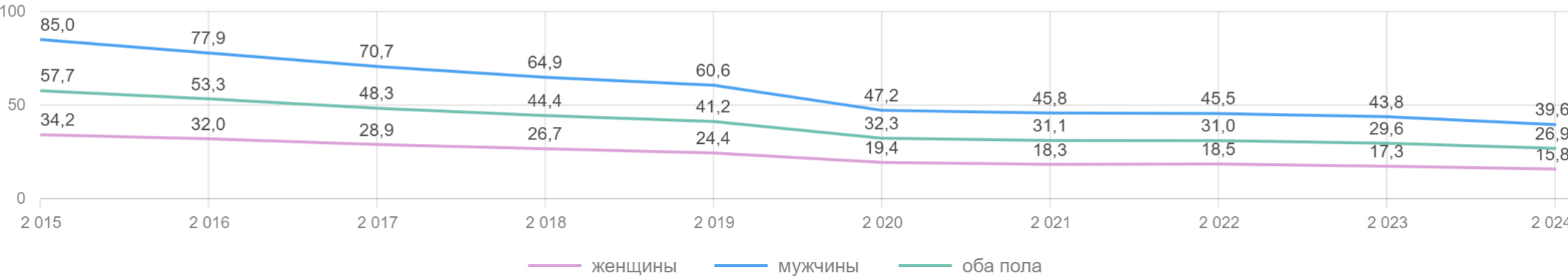
Что требует внимания

- Региональные различия могут скрывать проблемные субъекты.
- Спад 2020 года требует проверки — не артефакт ли это.

Вывод

За 30 лет РФ достигла снижения заболеваемости в 3,4 раза, распространённости — в 5,7 раза, смертности — в 6,4 раза.

ПЗ (все формы) по п...



Ключевые выводы

Основной тренд

За 2015–2024 гг. заболеваемость снизилась во всех группах:

Группа	2015	2024	Снижение
Оба пола	57,7	26,9	-53,4%
Мужчины	85,0	39,6	-53,4%
Женщины	34,2	15,8	-53,8%

Гендерная диспропорция

- Заболеваемость мужчин **в 2,5 раза выше**, чем у женщин.
- Разрыв сохраняется на всём периоде.

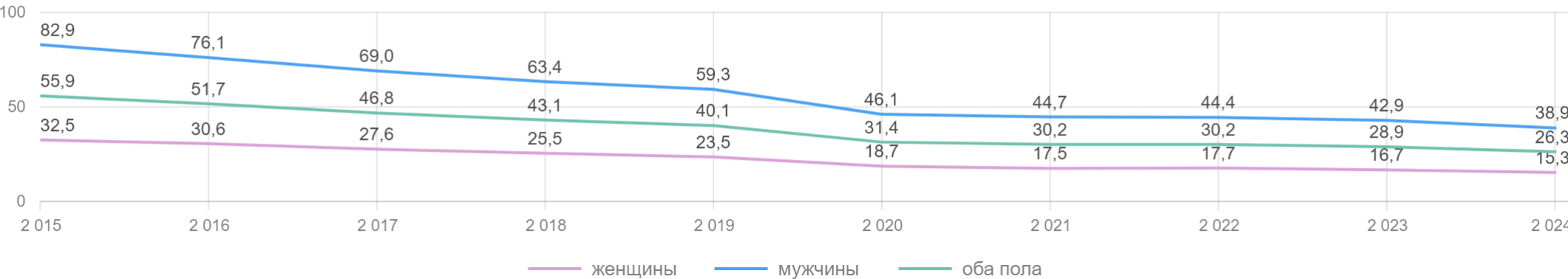
Ключевой период

- 2019 → 2020:** резкое снижение (вероятно, связано с пандемией COVID-19, а не с реальным улучшением).
- После 2020 года темпы снижения замедлились, но тренд остаётся положительным.

Вывод

Заболеваемость сократилась более чем вдвое. Однако **гендерный разрыв сохраняется** — необходимо усиление профилактики среди мужчин.

ПЗ органов дыхания по п...



Ключевые выводы

Основной тренд

За 2015–2024 гг. заболеваемость снизилась во всех группах:

Группа	2015	2024	Снижение
Оба пола	55,9	26,3	-53%
Мужчины	82,9	38,9	-53%
Женщины	32,5	15,3	-53%

⚠ Гендерная диспропорция

- Мужчины болеют **в 2,5 раза чаще** женщин.
- Соотношение остаётся **неизменным** на всём периоде.

Ключевые периоды

- 2019 → 2020 - Резкое снижение (вероятно, связано с пандемией COVID-19)
- 2021 → 2023 - Стабилизация (~30), незначительный рост у женщин в 2022 г.
- 2023 → 2024|Самый сильный спад за весь период (с 28,9 → 26,3)

Вывод

Эпидситуация улучшается, заболеваемость снижается. **Мужчины остаются основной группой риска** (заболеваемость в 2,5 раза выше). Требуются адресные профилактические программы для мужского населения.

ПЗ внелегочными формами - пол переключается селектором над графиком



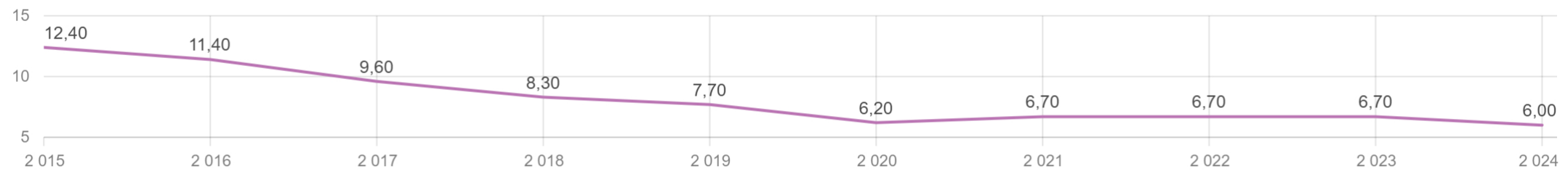
Ключевые выводы

Показатель	2015	2024	Снижение
Всего (оба пола)	1,8	0,61	-66%
Мужчины	2,0	0,72	-64%
Женщины	1,6	0,52	-68%
Кости и суставы	0,7	0,17	-76%
Мочеполовая система	0,4	0,09	-78%
Периферические лимфоузлы	0,3	0,14	-53%
ЦНС	0,1	0,07	-30%

Вывод

- **Внелегочный туберкулёз устойчиво снижается** за 10 лет.
- Наибольший прогресс — **костно-суставная** и **мочеполовая** формы (снижение на 76–78%).
- Заболеваемость **мужчин** выше, чем у женщин, но темпы снижения сопоставимы.
- Тяжёлые формы (ЦНС) остаются **стабильно редкими** (0,07 в 2024 г.).

Заболѳеваемость детского населения 0-14 лет в РФ - пол переключается селектором над графи...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Пол	2015	2024	Снижение
Оба пола	12,4	6,0	-52%
Мужчины	11,8	5,5	-53%
Женщины	13,0	6,6	-49%

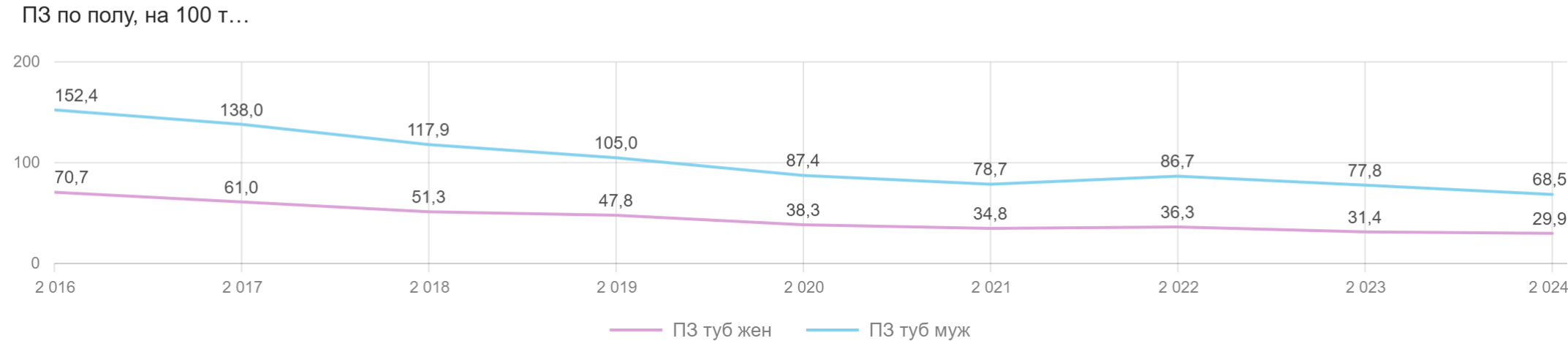
Ключевые периоды

- 2015 → 2019: активное снижение (12,4 → 7,4)
- 2020 → 2024: стабилизация (~6–7)

Вывод

- Заболѳеваемость детей снизилась вдвое за 10 лет — значительный успех.
- Мальчики болеют несколько реже девочек (5,5 против 6,6), но разница не критична.
- С 2020 года темпы снижения замедлились — выход на «плато».
- Для дальнейшего снижения требуются новые подходы и точечная работа с группами риска.

Ключевые выводы по эпидситуации, динамике, эффективности мер в Иркутской области



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Пол	2016	2024	Снижение
Мужчины	152,43	68,48	-55%
Женщины	70,67	29,88	-58%

Гендерное соотношение

- Мужчины болеют **в 2,2–2,3 раза чаще** женщин.
- Разрыв сохраняется на всём периоде.

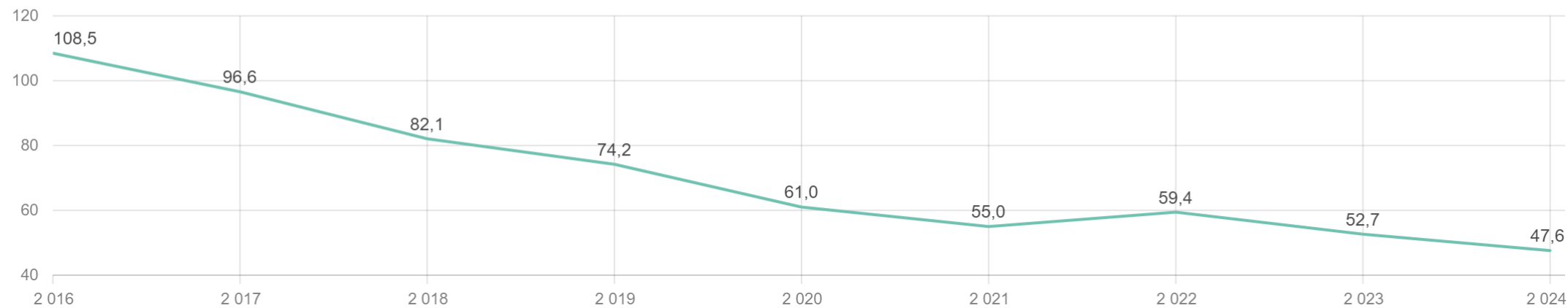
Особенности

- **2022 год:** небольшой рост заболеваемости у обоих полов (вероятно, эффект пандемии COVID-19).
- **2020 → 2021:** наиболее значительное снижение.

Вывод

Заболеваемость в ИО устойчиво снижается. Женщины демонстрируют чуть более высокий темп снижения (-58% против -55%). **Гендерный разрыв сохраняется** — мужчины остаются основной группой риска.

ПЗ всего, на 100 т...



Ключевые выводы

Основные показатели

2016 = 108,47 → 2024 = 47,59 **снижение за период-56%**

Динамика по годам

Период	Изменение
2016 → 2020	-44% (108,47 → 61,01)
2021 → 2022	+8,1% (единственный рост)

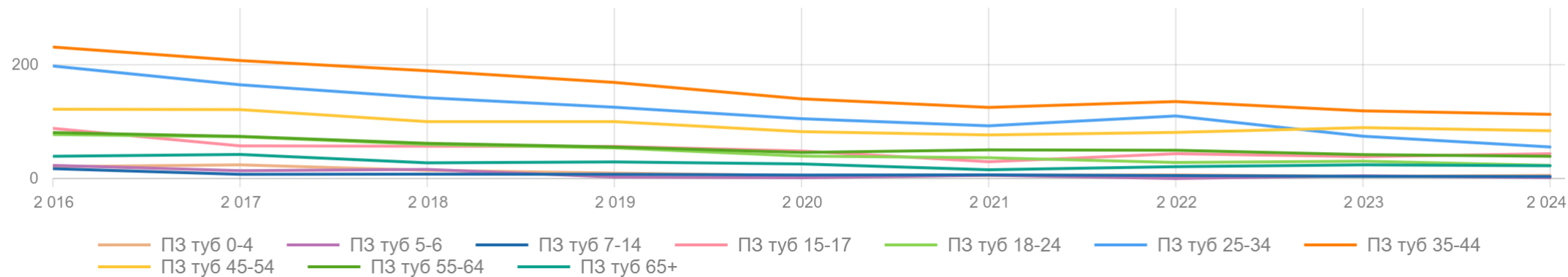
Ключевые наблюдения

- Заболеваемость снизилась **в 2,3 раза** за 9 лет.
- Максимальное снижение — **2019 → 2020 (-17,8%)**.
- Единственный рост — **в 2022 году (+8,1%)**, вероятно, следствие

Вывод

Устойчивое снижение заболеваемости в ИО (-56% за 9 лет) свидетельствует об эффективности профилактических программ. Рост в 2022 году требует мониторинга, но тренд остаётся положительным.

ПЗ по возрастным группам, на 100 т...



Ключевые выводы

Возраст	2016	2024	Снижение
0–4 года	20,68	5,48	в 3,8 раза
5–6 лет	23,12	1,62	в 14 раз
7–14 лет	17,43	3,55	в 4,9 раза
15–17 лет	44,01	21,81	-50%
18–24 года	77,29	22,94	в 3,4 раза
25–34 года	197,89	55,39	в 3,6 раза
35–44 года	231,15	112,70	-51%

- Ключевые наблюдения
- Наиболее значительное снижение — в группе 5–6 лет (в 14 раз).
 - Самые высокие показатели на всём периоде — в группах 25–34 и 35–44
 - Нулевой показатель в группе 5–6 лет в 2022 г. (возможно, артефакт данных).

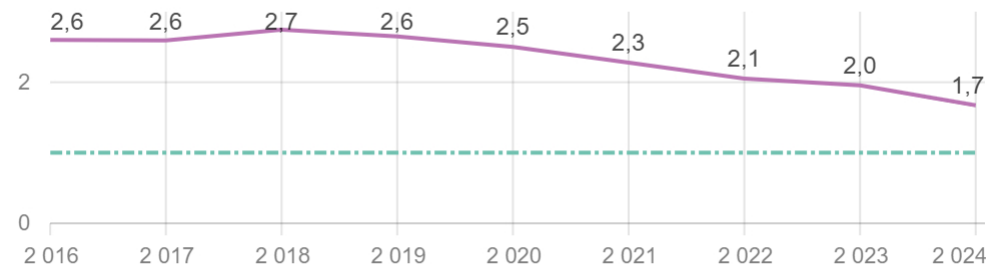
Вывод

Заболееваемость снизилась во всех возрастных группах. Основная группа риска — взрослые 25–44 года. Детская заболеваемость снизилась наиболее выражено.

ПЗ и ОЗ, на 100 ...



Коэффициент хронизации (ОЗ/ПЗ)



Ключевые выводы

Общая характеристика

- На графике «ПЗ и ОЗ» представлены 20+ форм туберкулёза (все формы, ТОД, лёгкие, внелегочный, ФКТ, распад, МЛУ и др. в разбивке по возрастам).
- На графике «Хронизация» (ОЗ/ПЗ) показано соотношение накопления контингентов для каждой формы.
-

Ключевые выводы (в целом)

- **ПЗ и ОЗ** - Устойчивое снижение по большинству форм
- **Хронизация (ОЗ/ПЗ)** - В целом >1 , что свидетельствует о накоплении контингентов и эффективности лечения

Детализация по формам

Для анализа конкретных форм туберкулёза (ТОД, лёгкие, внелегочный, ФКТ, распад, МЛУ) **используйте селектор «Формы туберкулёза»**.

При выборе формы на графиках отображаются:

- динамика ПЗ и ОЗ (две линии)
- коэффициент хронизации (ОЗ/ПЗ) с порогом $Y=1$

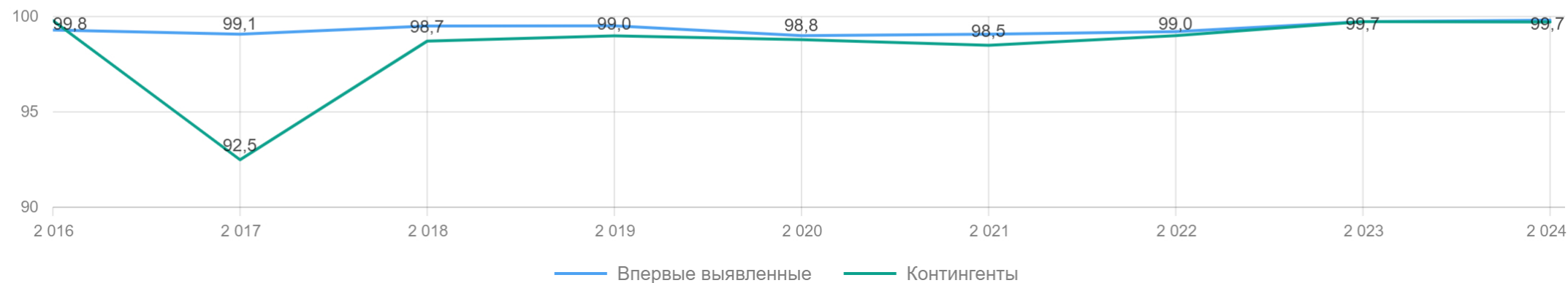
Общий вывод

В Иркутской области **наблюдается устойчивое снижение заболеваемости и накопление контингентов** по всем формам туберкулёза. Наиболее выраженное улучшение — по детским и подростковым формам. Для углублённого анализа конкретных нозологий рекомендуется использовать селектор.

Совет

Ввиду большого количества форм (более 20) детальный анализ по каждой форме не проводится. Пользователь может выбрать интересующую форму с помощью селектора и оценить динамику ПЗ/ОЗ и коэффициента хронизации. Общий тренд по всем формам — снижение заболеваемости и накопление контингентов.

Охват обследованием на ВИЧ, % - возрастная группа переключается селектором над графиче...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Возрастная группа	2016	2024	Тренд
Всего (ВВБ / контингенты)	99,3% / 99,8%	99,8% / 99,7%	стабильно высокий
Дети 0–14 лет	100% / 100%	100% / 100%	стабильный, кроме 2022 г.
Подростки 15–17 лет	93,9% / 94,4%	100% / 100%	восстановился после спада

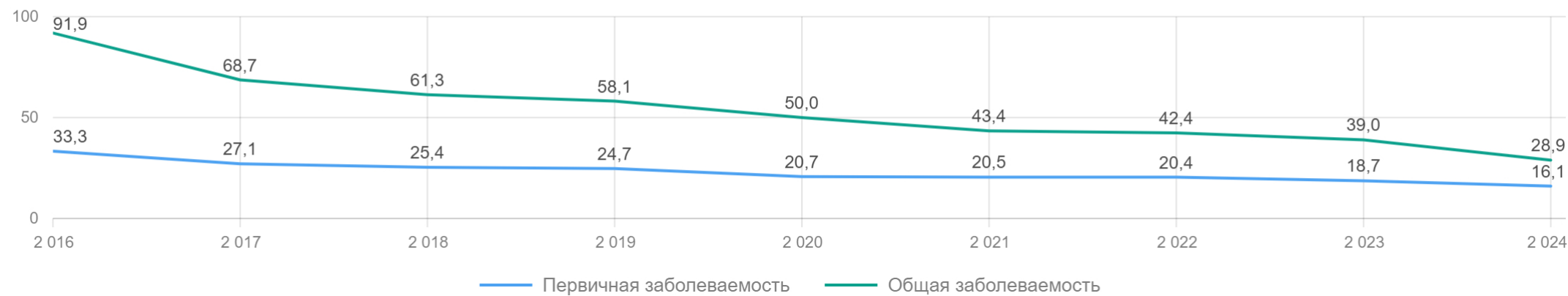
Ключевые наблюдения

- Всего: охват стабильно высокий (99–100%) на всём периоде.
- Дети 0–14:
 - 2016–2024 — почти всегда 100%.
 - 2022 год — резкий спад (ВВБ: 65%, контингенты: 72%), после чего восстановление до 100%.
- Подростки 15–17:
 - 2020 год — падение контингентов до 67% (при 100% по ВВБ).
 - 2022 год — синхронное снижение (94% / 86%).
 - К 2024 году восстановление до 100%.

Вывод

Общий охват обследованием на ВИЧ стабильно высокий (99–100%). У детей и подростков наблюдались временные спады в 2020–2022 гг., вероятно, связанные с пандемией COVID-19. К 2024 году все показатели восстановились до 100%.

ПЗ и ОЗ ТБ+ВИЧ, на 100 тыс. - возрастная группа переключается селектором над графи...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Возрастная группа	2016	2024	Снижение
Всего (ПЗ / ОЗ)	33,3 / 91,9	16,1 / 28,9	-52% / -69%
Дети 0–14 лет	0,4 / 1,0	0,2 / 0,6	нестабильно
Подростки 15–17 лет	0 / 1,3	0 / 0	эпизодически

Вывод

ТБ+ВИЧ в ИО устойчиво снижается: ПЗ — на 52%, ОЗ — на 69% за 9 лет. У детей и подростков заболеваемость носит эпизодический характер, с единичными случаями. **Резкое снижение ОЗ в 2024 году требует подтверждения**, но общий тренд положительный.

Ключевые наблюдения

Всего:

- Устойчивое снижение ПЗ и ОЗ (ОЗ снижается быстрее — на 69%).
- Резкое ускорение снижения в **2023 → 2024** (ОЗ: 38,9 → 28,9).

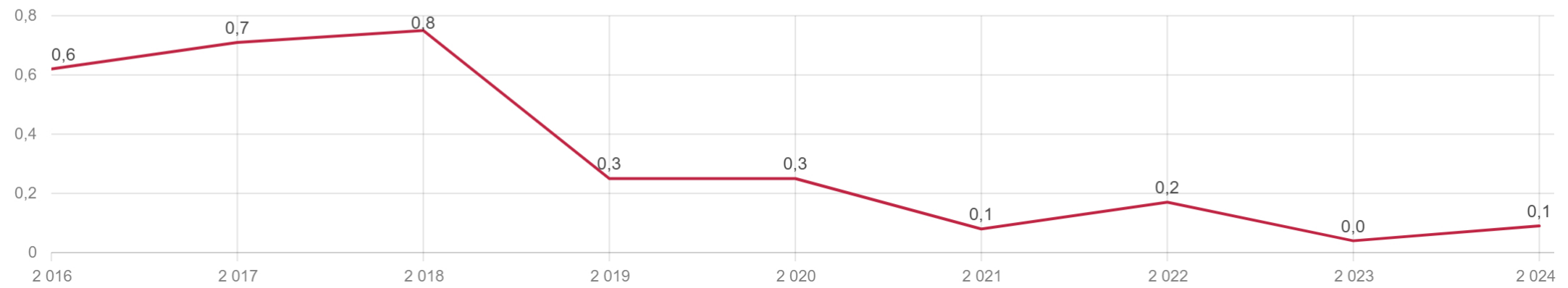
Дети 0–14:

- Пик в 2018 г. (ОЗ = 3,02), затем снижение.
- 2020 год — ОЗ = 0** (вероятно, артефакт данных из-за пандемии).
- С 2021 г. показатели стабильно низкие (0,2–0,6).

Подростки 15–17:

- Эпизодическая заболеваемость (пик 2,5 в 2018 г.).
- 2017, 2021, 2022, 2024 гг. — заболеваемость отсутствует.**
- С 2018 г. ПЗ и ОЗ синхронны.

Смертность ТБ+ВИЧ от туберкулёза, на 100 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Год	Показатель
2016	0,62
2018 (пик)	0,75
2020	0,25
2023 (мин)	0,04
2024	0,09

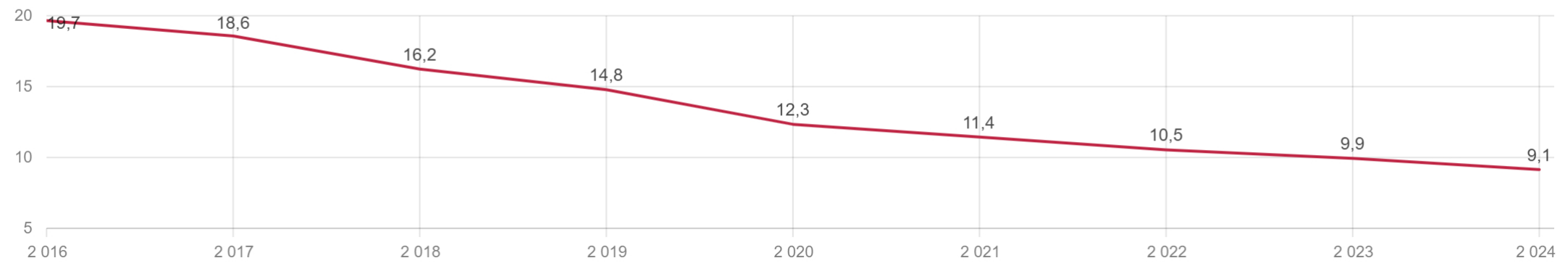
 **Ключевые наблюдения**

- **Снижение за 8 лет: около 93%** (с 0,62 до 0,04–0,09).
- **Пик:** 2016–2018 гг. (0,62–0,75).
- **Резкое снижение:** 2019–2020 гг. (с 0,75 до 0,25, -67%).
- **Стабилизация на низком уровне:** 2021–2024 гг. (0,04–0,09).

Вывод

Смертность от туберкулёза среди больных ТБ+ВИЧ снизилась более чем в 10 раз за 8 лет. Это может свидетельствовать об эффективности программ раннего выявления, антиретровирусной терапии и улучшении качества лечения сочетанной патологии. Стабилизация на минимальных значениях (0,04–0,09) — положительный тренд.

Смертность ТБ+ВИЧ от других причин, на 100 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Год	Показатель
2016	19,66
2024	9,14

Ключевые наблюдения

- Устойчивое снижение на всём периоде.
- Темпы снижения замедляются в последние годы (2021–2024).

- Снижение за 8 лет: -53,5% (более чем в 2 раза)

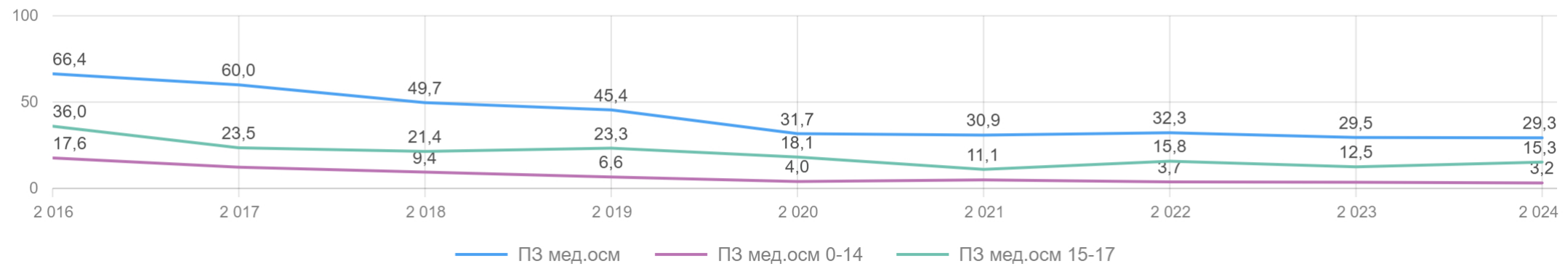
Ключевые периоды

2019 → 2020 - **-2,44** (наиболее значительное снижение)
2021 → 2022 - **-0,90**
2022 → 2023 - **-0,61**
2023 → 2024 - **-0,79**

Вывод

Смертность от других причин среди больных ТБ+ВИЧ снизилась вдвое за 8 лет. Это может свидетельствовать об улучшении общего состояния здоровья пациентов и качества медицинской помощи. Замедление темпов снижения в последние годы требует мониторинга.

ПЗ по данным медосмотров , на 100 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Группа	2016	2024	Снижение
Всего	66,41	29,31	-56%
Дети 0–14 лет	17,62	3,19	-82%
Подростки 15–17 лет	36,01	15,26	-58%

Ключевые наблюдения

- Самые высокие темпы снижения — у детей 0–14 лет (в 5,5 раза).
- 2020 год — резкое падение у всех групп (вероятно, связано с пандемией COVID-19).
- Подростки (15–17 лет):
 - Минимум в 2021 г. (11,06).
 - 2022–2024 гг. — небольшой рост / стабилизация (12–15).

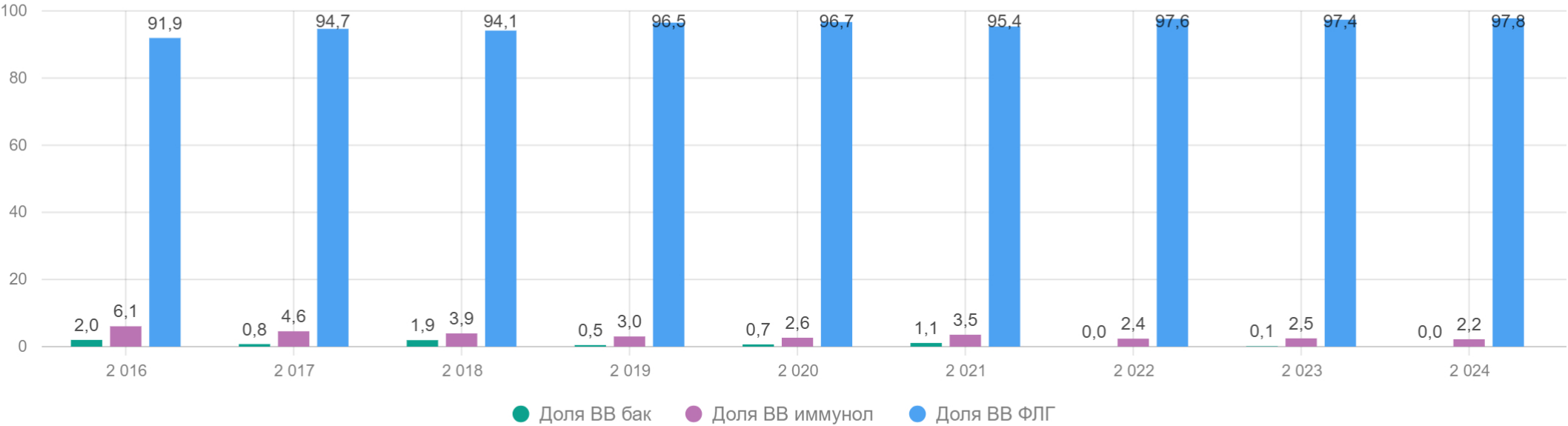
Тревожные сигналы

- Снижение охвата профилактическими осмотрами **более чем в 2–5 раз** за 8 лет.
- Детская группа — критическое снижение (в 5,5 раза).

Вывод

Выявляемость при профилактических осмотрах значительно снизилась во всех возрастных группах. Наиболее критическая ситуация — у детей 0–14 лет (-82%). Это может быть связано как с объективными причинами (пандемия, изменения в методике учёта), так и с реальным снижением заболеваемости. **Требуется углублённый анализ причин и корректировка профилактических программ.**

Доля ВВ по методам выявления...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Метод	2016	2024	Тренд
Флюорография (ФЛГ)	91,94%	97,80%	рост
Иммунологические	6,06%	2,20%	снижение
Бактериологические	2,00%	0,00%	стремится к нулю

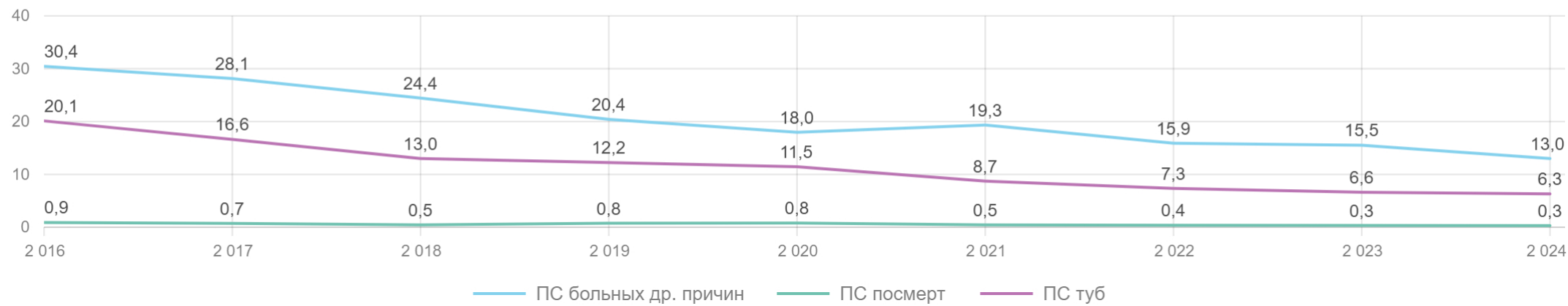
Ключевые наблюдения

- **ФЛГ — основной метод выявления:** доля выросла с 92% до 98% за 8 лет.
- **Иммунологические методы (проба Манту, Диаскинтест)** теряют роль в первичной диагностике (с 6% до 2%).
- **Бактериологические методы** используются крайне редко для первичного выявления (в 2022 и 2024 гг. — 0%).

Вывод

Флюорография остаётся главным инструментом скрининга туберкулёза в ИО, укрепляя свои позиции (92% → 98%). Роль иммунологических и бактериологических методов в первичном выявлении снижается, что может быть связано с изменением клинических рекомендаций и фокусом на инструментальную диагностику. Нулевые значения бактериологических методов требуют проверки

Смертность от туберкулеза, других причин, посмертная диагностика, на 100 тыс.



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Показатель	2016	2024	Снижение
Смертность от туберкулёза	20,12	6,31	-69%
Смертность от других причин	30,45	13,00	-57%
Посмертная диагностика	0,91	0,30	-67%

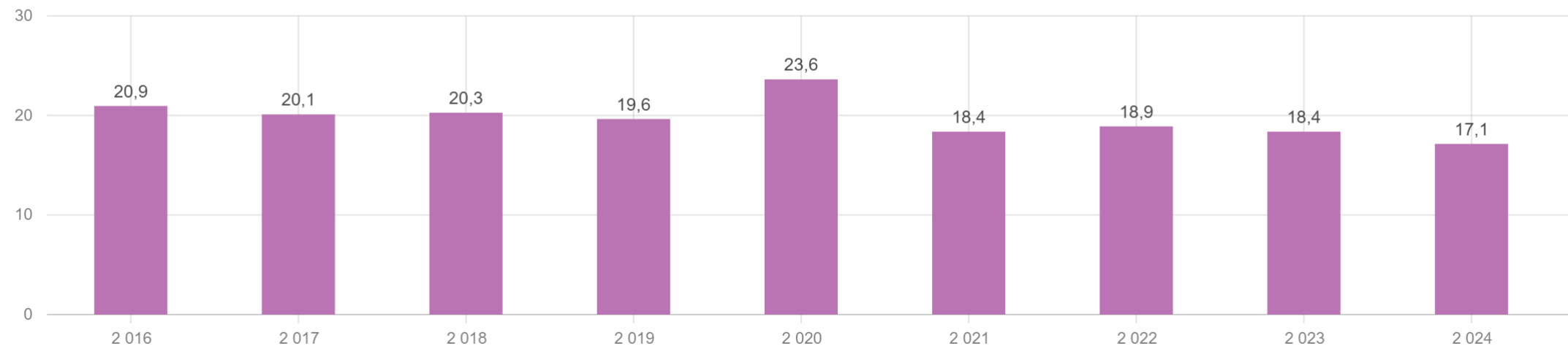
Ключевые наблюдения

- Наиболее значительное снижение — смертность от туберкулёза (-69%).
- Посмертная диагностика — стабильно низкий уровень (<1) с тенденцией к снижению (0,91 → 0,30).
- 2020 год — пик посмертной диагностики (0,8), вероятно, связан с пандемией COVID-19.

Вывод

Все показатели устойчиво снижаются. Снижение посмертной диагностики (на 67%) свидетельствует об **улучшении прижизненного выявления**. Комплексное снижение смертности от туберкулёза и других причин говорит о повышении качества медицинской помощи и общего состояния здоровья пациентов.

Доля умерших до 1 года на учёт...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Год	Показатель
2016	20,95
2019	19,64
2020 (пик)	23,62
2024 (минимум)	17,14

Ключевые наблюдения

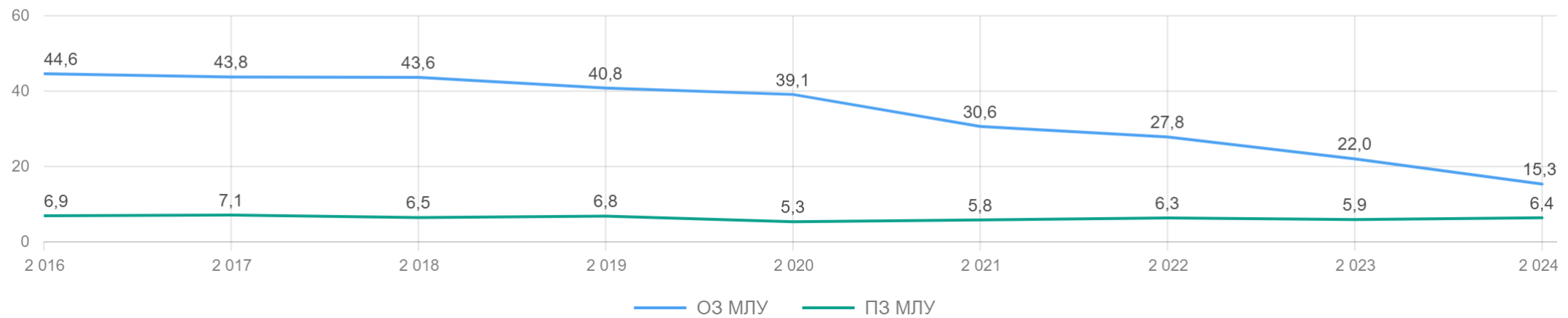
- **2016–2019:** стабильный уровень (19,6–21,0).
- **2020 год — резкий скачок до 23,62** (вероятно, влияние пандемии COVID-19).
- **2021–2024:** устойчивое снижение (18,37 → 17,14).

- **Снижение за 8 лет: -18%** (20,95 → 17,14)

Вывод

Доля умерших в первый год учёта снижается (с 20,95 до 17,14). Исключение — **пик в 2020 году** (23,62), связанный с пандемией. После 2020 года тренд восстановлен, показатель достиг минимума в 2024 г. Это свидетельствует об улучшении качества диагностики и лечения на ранних этапах.

ПЗ и ОЗ МЛУ, на 100 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Показатель	2016	2024	Изменение
ОЗ МЛУ	44,63	15,32	-66% (в 2,9 раза)
ПЗ МЛУ	6,93	6,39	стабильно (5,3–7,1)

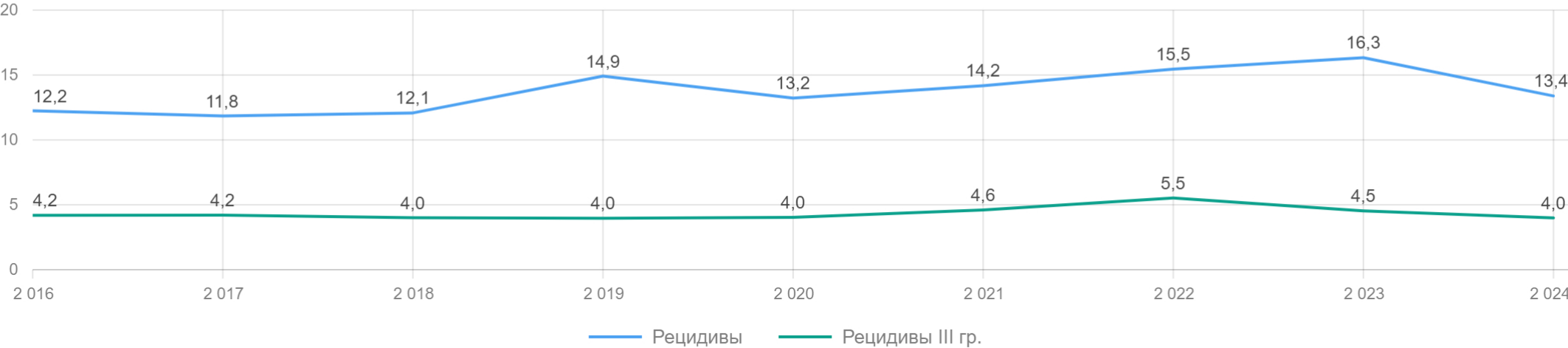
Ключевые наблюдения

- ОЗ МЛУ (распространённость МЛУ) — устойчивое и значительное снижение (на 66%).
- ПЗ МЛУ (первичная заболеваемость МЛУ) — стабильна на всём периоде (5,3–7,1).
- Ускорение снижения ОЗ МЛУ — в 2020–2021 гг. (вероятно, влияние пандемии).

Вывод

Распространённость МЛУ в ИО снизилась почти в 3 раза. Однако первичная заболеваемость МЛУ остаётся стабильной, что указывает на сохраняющуюся проблему лекарственной устойчивости среди новых случаев. Требуются дополнительные меры для снижения ПЗ МЛУ.

Рецидивы (всего и из III группы), на 100 т...



Ключевые выводы



Ключевые показатели

Показатель	2016	2024	Максимум
Всего рецидивов	12,24	13,39	16,34 (2023)
Рецидивы из III	4,19	3,99	5,52 (2022)



Ключевые наблюдения

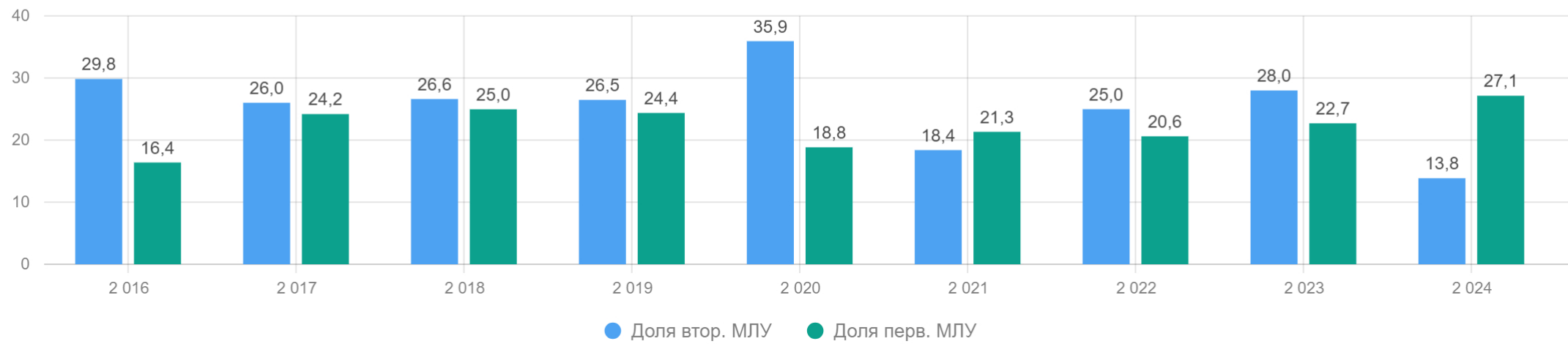
- **2016–2018:** относительная стабильность.
- **2018–2023:** рост обоих показателей (пик: 2022–2023 гг.).
- **2024 год — значительное снижение** (общие рецидивы: 16,34 → 13,39; III группа: 5,52 → 3,99).
- Доля рецидивов из III группы — **25–36%** от общего числа.



Вывод

После пика в 2022–2023 гг. частота рецидивов в 2024 году снизилась. Рост в предыдущие годы может быть связан с последствиями пандемии COVID-19. Снижение в 2024 году требует закрепления через усиление профилактических и лечебных программ.

Доля больных ТОД с МЛ...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Тип МЛУ	2016	2024	Тренд
Первичная МЛУ	16,39%	27,14%	рост
Вторичная	29,84%	13,85%	снижение (в 2

Ключевые наблюдения

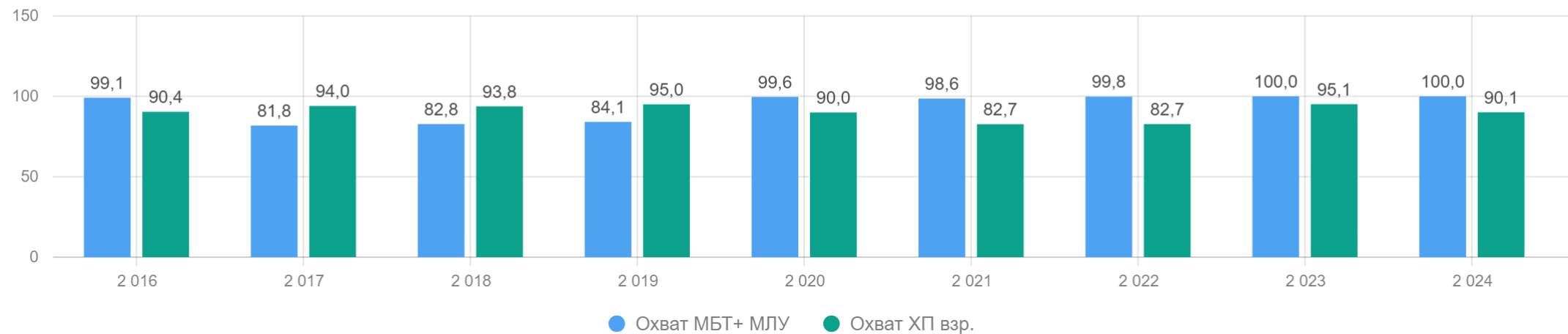
- 2016–2019: вторичная МЛУ выше первичной.
- 2020 год — пик вторичной МЛУ (35,93%) (вероятно, влияние пандемии).
- К 2024 году: первичная МЛУ (27,14%) почти вдвое превысила вторичную (13,85%).

Вывод

Положительный момент: доля вторичной МЛУ снизилась в 2 раза — улучшение контроля лечения и профилактики рецидивов.

Тревожный сигнал: первичная МЛУ выросла с 16% до 27%. Это указывает на возможное увеличение передачи устойчивых штаммов. Требуется усиление мер по раннему выявлению и инфекционному контролю.

Охват МЛУ и химиопрофилактики,...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Показатель	2016	2024	Тренд
Охват МБТ+ МЛУ	99,12%	100%	стабильно высокий
Охват ХП взр.	90,36%	90,08%	стабильный

Сравнительный анализ

Период	Охват МБТ+ МЛУ	Охват ХП взр.	Вывод
2016–2019	99% → 84%	90% → 95%	Разнонаправленная динамика
2020–2022	≈99%	83–90%	Приоритет — лечению сложных форм

Ключевые наблюдения

Охват МБТ+ МЛУ:

- Стабильно высокий уровень (99–100% с 2020 г.).
- 2023–2024 гг. — 100% (полный охват).

Охват химиопрофилактикой взрослых:

- Периоды высокого охвата: 2018–2019 (93–95%), 2023 (95%).
- Спады: 2021–2022 гг. (до 82,7%).
- 2024 год: 90,1% (ниже пиковых значений).

Вывод

Охват пациентов с МЛУ максимален (100%). Это свидетельствует о высоком качестве работы с лекарственно-устойчивыми формами.

Охват химиопрофилактикой взрослых менее стабилен (спады до 82,7% в 2021–2022 гг., вероятно, из-за пандемии). Восстановление до 95% в 2023 году положительно, но в 2024 году снова снижение до 90%. Требуется усиление профилактических программ.

Клиническое излечение и абацилирование ТОД,...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Показатель	2016	2024	Рост
Клиническое излечение	41,13%	79,52%	+38,4 п.п.
Абацилирование	51,17%	87,46%	+36,3 п.п.

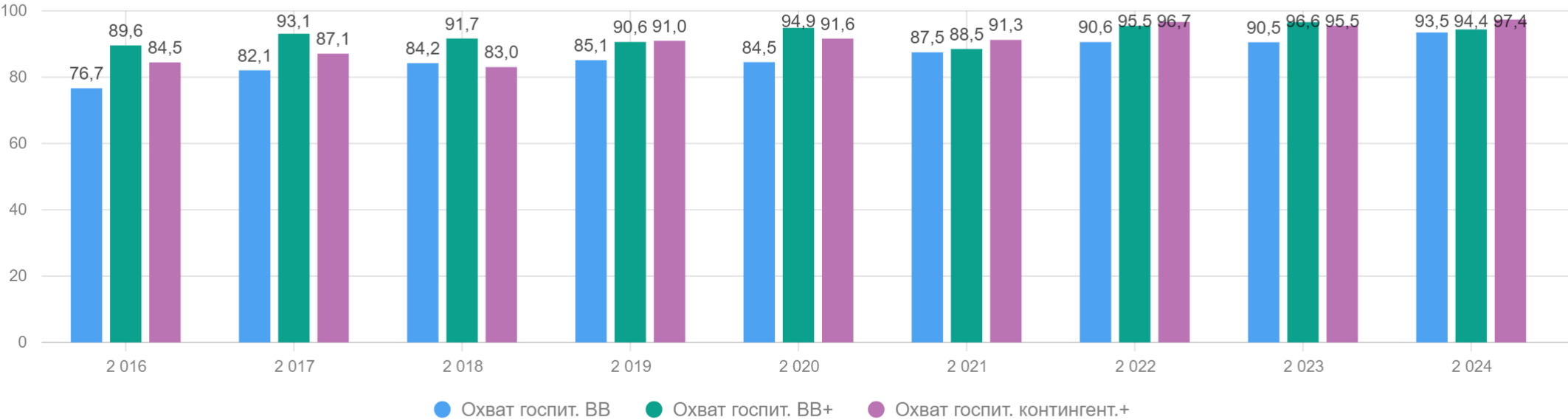
Ключевые наблюдения

- Устойчивый рост обоих показателей на всём периоде.
- Наиболее значительный скачок — 2023–2024 гг.:
 - Абацилирование: 74% → 87%
 - Клиническое излечение: 53% → 80%
- Разрыв между показателями сократился с 10 п.п. (2016) до 8 п.п. (2024).

Вывод

Эффективность лечения туберкулёза в ИО значительно выросла за 9 лет. Клиническое излечение увеличилось почти вдвое (41% → 80%), абацилирование — с 51% до 87%. Особенно заметен прогресс в 2023–2024 гг. Это свидетельствует об улучшении качества медицинской помощи и программ лечения.

Охват госпитализацией больных туберкулёзом,...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Категория	2016	2024	Рост
Впервые выявленные (BB)	76,65%	93,48%	+16,8 п.п.
Впервые выявленные с МБТ+ (BB+)	89,58%	94,40%	+4,8 п.п.

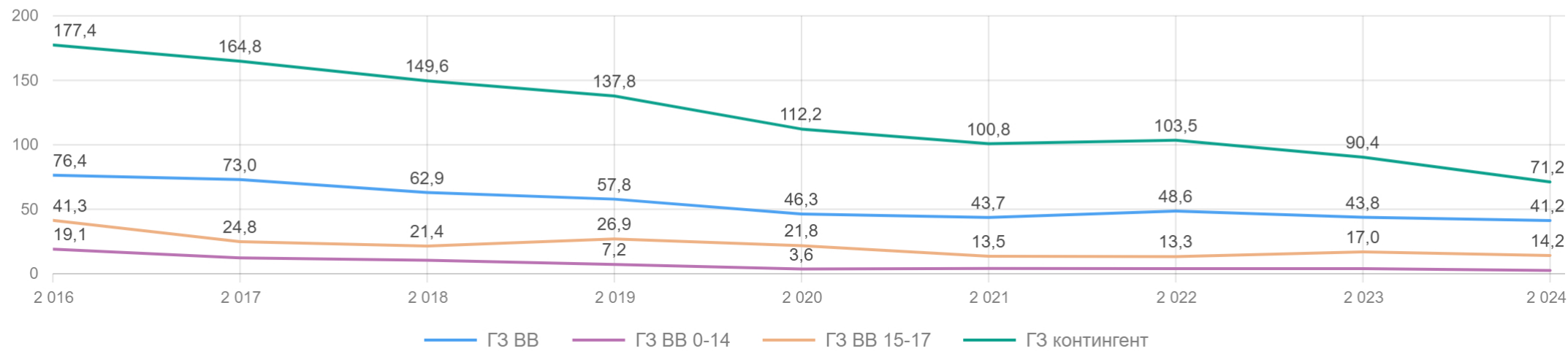
Ключевые наблюдения

- **Все показатели выросли.** Самый значительный рост — у впервые выявленных (BB: +17 п.п.).
- **Разрыв между показателями сократился** с 13 п.п. (2016) до 3 п.п. (2024) — система стала сбалансированной.
- **Контингенты с МБТ+** достигли рекордного охвата — **97,4%** в 2024 г.
- **2021 год** — единственное снижение показателя BB+ (94,9% → 88,5%), при этом другие показатели росли.

Вывод

Охват госпитализацией в ИО устойчиво растёт. К 2024 году все категории пациентов охвачены на **93–97%**, что свидетельствует о практически полном охвате целевых групп и выравнивании системы помощи. Аномалия 2021 года (BB+) требует мониторинга, но общий тренд положительный.

Госпитализированная заболеваемость туберкулёзом, на 100 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Категория	2016	2024	Снижение
ГЗ BB (впервые выявленные)	76,40	41,24	-46%
ГЗ контингент	177,36	71,19	-60%
ГЗ BB 0-14 (дети)	19,05	2,55	-87%
ГЗ BB 15-17 (подростки)	41,34	14,17	-66%

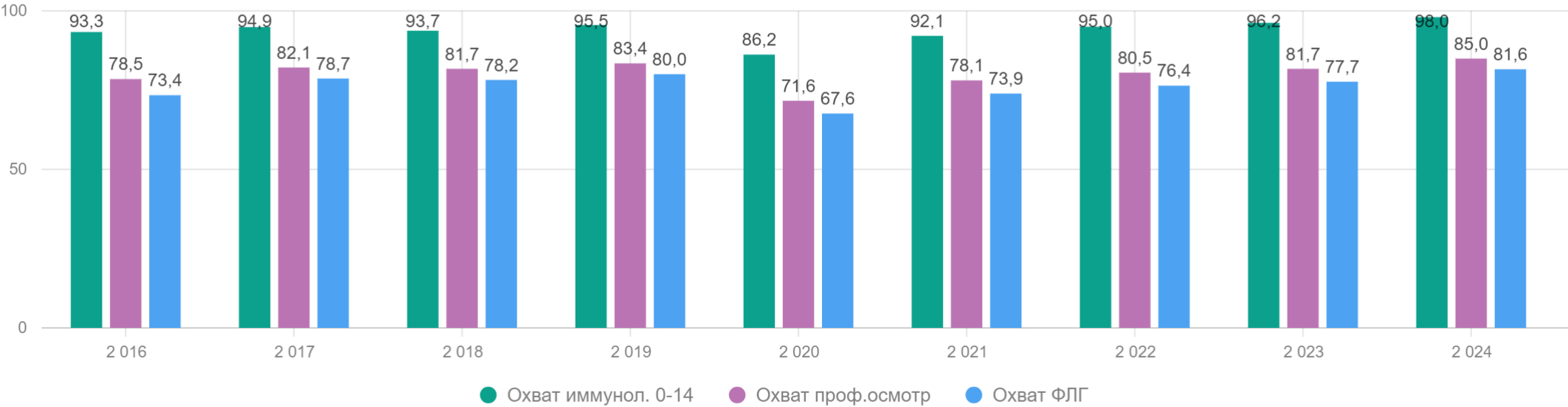
Ключевые наблюдения

- Наиболее значительное снижение — у детей 0–14 лет (-87%).
- ГЗ контингент снизился в 2,5 раза (с 177 до 71).
- 2020 год — резкое снижение всех показателей (вероятно, влияние пандемии COVID-19).
- 2022 год — небольшой рост ГЗ BB (43,7 → 48,6), затем снижение продолжилось.

Вывод

Госпитализированная заболеваемость в ИО устойчиво снижается по всем категориям. Особенно впечатляющий прогресс — у детей (-87%) и контингентов (-60%). Это свидетельствует об эффективности профилактических и лечебных программ.

Охват профосмотрами (население, дети, ФЛГ)...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Категория	2016	2024	Рост
Иммунодиагностика (дети 0–14 лет)	93,33%	98,03%	+4,7 п.п.
Профосмотры (все население)	78,49%	84,95%	+6,5 п.п.

Ключевые наблюдения

- Все показатели выросли за 9 лет.
- Самый высокий охват — иммунодиагностика детей (98%).
- Самый низкий — ФЛГ взрослых (81,6%), но разрыв сокращается.
- 2020 год — резкий спад (вероятно, из-за пандемии COVID-19):
 - Иммунодиагностика: 95,5% → 86,2%
 - Профосмотры: 83,4% → 71,6%
 - ФЛГ: 80,0% → 67,6%
- После 2020 года — восстановление и достижение максимумов в 2024 г.

Вывод

Охват профилактическими осмотрами устойчиво растёт. Несмотря на значительный спад в 2020 году из-за пандемии, к 2024 году все показатели превысили допандемийный уровень и достигли максимумов за 9 лет. Это свидетельствует о восстановлении и усилении системы профилактики туберкулёза.

Выявляемость (ФЛГ и бактериоскопия), на 1000 осмотренн...



Ключевые выводы

Ключевые показатели (на 1000 осмотренных)

Метод	2016	2024	Тренд
ФЛГ	1,08	0,46	устойчивое снижение
Бактериоскопия	3,43	12,08	нестабильно, резкие скачки

Разрыв между методами

- 2016–2019: показатели сопоставимы (2–3,5).
- С 2020 года: бактериоскопия многократно (в 10–26 раз) выше ФЛГ.

Вывод

Выявляемость ФЛГ устойчиво снижается (вероятно, из-за уменьшения охвата скринингом). **Бактериоскопия демонстрирует резкие скачки**, что может указывать на изменения в методике лабораторной диагностики или подтверждение клинически заподозренных случаев, а не активный поиск. Требуется анализ причин роста разрыва между методами.

Ключевые наблюдения

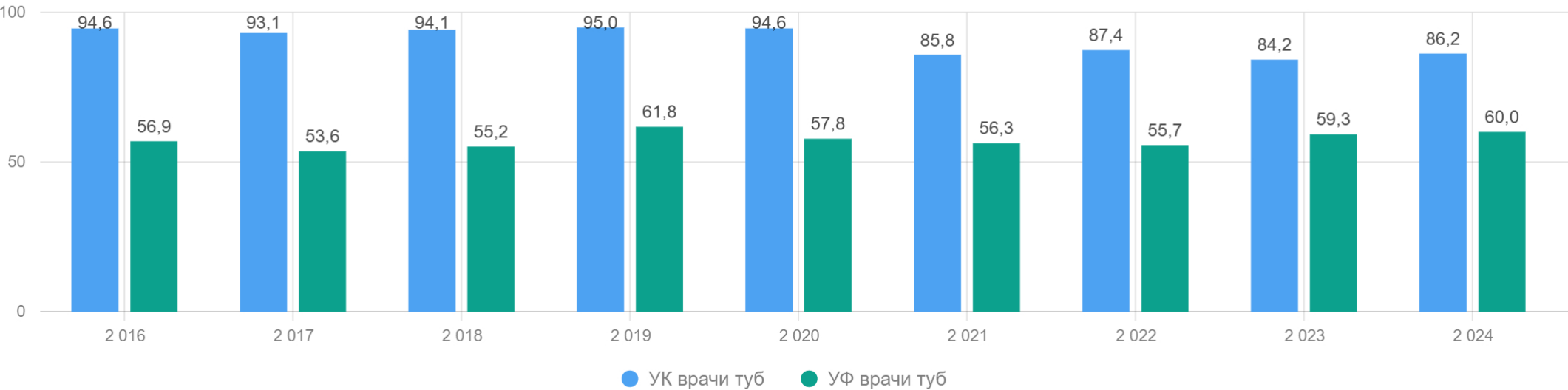
ФЛГ:

- Стабильное снижение с 1,08 до 0,46 за 9 лет.
- Возможные причины: сокращение охвата профилактическими осмотрами.

Бактериоскопия:

- Крайне нестабильный показатель.
- Пики: 2020 г. (11,66), 2022 г. (10,24), 2024 г. (12,08).
- Минимум: 2018 г. (1,03).

Укомплектованность фтизиатрами,...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Показатель	2016	2024	Тренд
УК (кадры)	94,62%	86,23%	снижение (с 2021 г. ≈85–87%)
УФ (физические	56,94%	60,05%	стабильно низкий

Разрыв между показателями

- Постоянный разрыв **≈30 п.п.** (физических лиц значительно меньше, чем ставок).
- Это отражает хронический дефицит врачей-фтизиатров.

Вывод

Укомплектованность кадрами снизилась с 95% до 85% после 2020 года (вероятно, влияние пандемии).
Укомплектованность физическими лицами остаётся критически низкой (55–60%) с незначительным улучшением.
Сохраняющийся разрыв в 30 п.п. свидетельствует о высокой нагрузке на работающих врачей и требует кадрового усиления службы.

Ключевые наблюдения

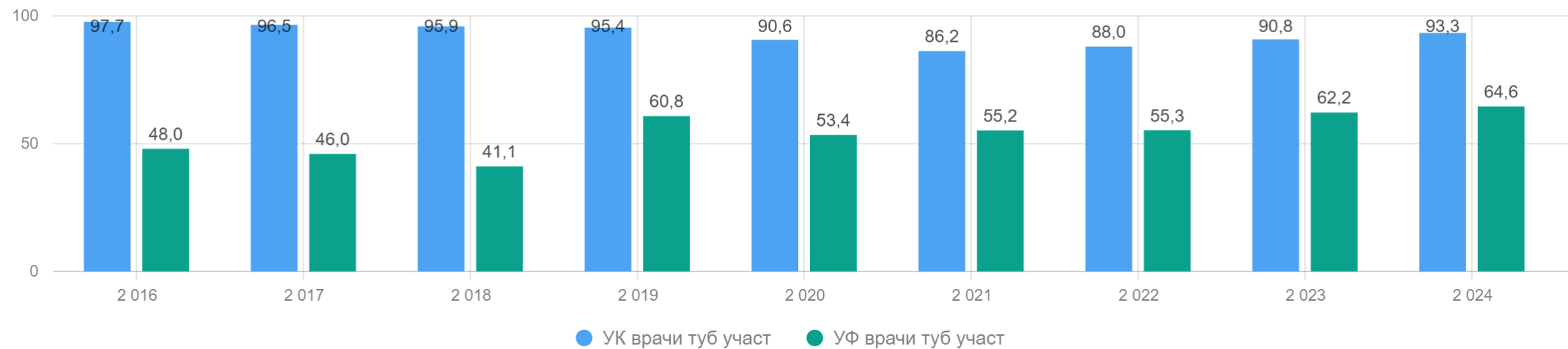
УК врачи туб (укомплектованность кадрами):

- 2016–2020: **стабильно высокий уровень** (93–95%).
- 2021 год — резкое снижение до 85,8%**, после чего стабилизация (84–87%).

УФ врачи туб (укомплектованность физическими лицами):

- Стабильно низкий уровень** (54–62%).
- Незначительный рост в последние годы (56% → 60%).

Укомплектованность фтизиатрами участковыми,...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Показатель	2016	2024	Тренд
УК (кадры)	97,67%	93,33%	снижение, затем рост
УФ (физические)	48,00%	64,56%	значительный рост

Разрыв между показателями

- 2016: разрыв 49,7 п.п. (97,7% vs 48,0%).
- 2024: разрыв сократился до 28,8 п.п. (93,3% vs 64,6%).
- Это свидетельствует о **целенаправленной работе по привлечению профильных специалистов**.

Вывод

Укомплектованность физическими лицами выросла с 48% до 65% — значительный прогресс. Общая укомплектованность после спада в 2021 году восстановилась до 93%. Разрыв между показателями сократился вдвое, что говорит об успешной кадровой политике. Однако укомплектованность физическими лицами (65%) остаётся ниже целевых значений.

Ключевые наблюдения

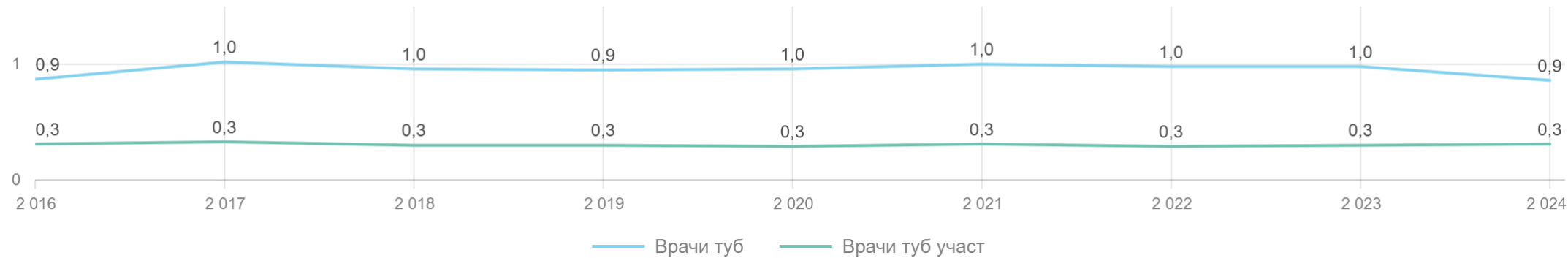
УК врачи туб участ (укомплектованность кадрами):

- 2016–2019: стабильно высокий уровень (95–98%).
- 2021 год — минимум (86,2%)** (вероятно, влияние пандемии).
- 2022–2024: восстановление до 93%.**

УФ врачи туб участ (укомплектованность физическими лицами):

- 2016–2018: низкий уровень (41–48%).
- 2019 год — резкий скачок до 60,8%.**
- 2022–2024: устойчивый рост до 64,6%** (максимум за период).

Обеспеченность фтизиатрами, 10 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Категория	2016	2024	Тренд
Врачи туб (всего)	0,87	0,86	стабильно ≈0,9
Врачи туб участковые	0,31	0,31	стабильно 0,29–0,33

Дисбаланс

- Общих врачей-фтизиатров в 2,8–3,2 раза больше, чем участковых.
- Это может указывать на концентрацию кадров в стационарном звене, а не на первичном.

Вывод

Обеспеченность врачами-фтизиатрами стабильна до 2023 г. (≈1,0), но в 2024 году снизилась до 0,86 — требует мониторинга. Участковая служба сохраняет стабильность (≈0,3). Дисбаланс в пользу общих фтизиатров (в 3 раза больше участковых) может указывать на недостаток кадров в первичном звене.

Ключевые наблюдения

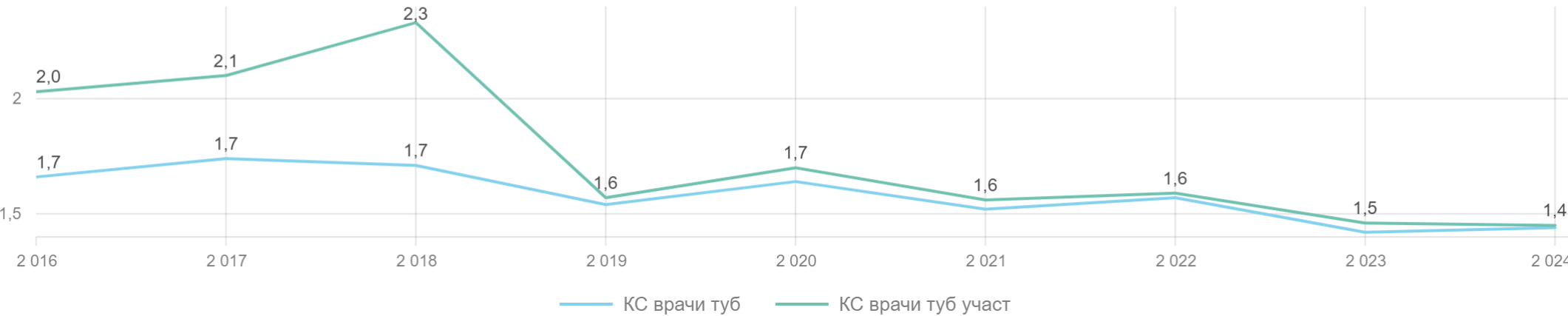
Врачи-фтизиатры (всего):

- 2016–2023: стабильно 0,95–1,02.
- 2024 год — снижение до 0,86 (минимум за период).

Участковые врачи-фтизиатры:

- Высокая стабильность — весь период в диапазоне 0,29–0,33.
- К 2024 году — 0,31.

Коэффициент совместительст...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Категория	2016	2024	Снижение
KS врачи туб (всего)	1,66	1,44	-13%
KS врачи туб участковые	2,03	1,45	-29%

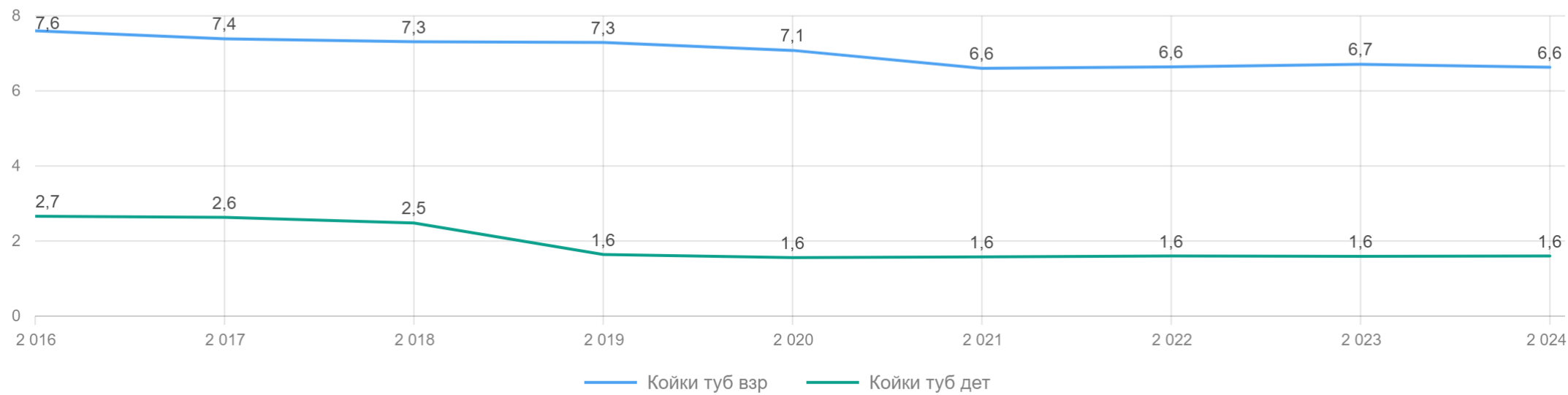
Ключевые наблюдения

- Оба показателя снизились за 9 лет.
- Наиболее значительное снижение — у участковых врачей (с 2,03 до 1,45, -29%).
- Пик — 2017–2018 гг.
- Наиболее резкое снижение — в 2019 г., после чего стабилизация на более низком уровне.
- 2023–2024 гг. — практически без изменений (возможен выход на «плато»).

Вывод

Коэффициент совместительства снижается, особенно среди участковых врачей (-29%). Это может свидетельствовать о сокращении кадрового потенциала фтизиатрической службы. Стабилизация в 2023–2024 гг. требует мониторинга — является ли это новой нормой или временной паузой. Необходимо оценить, как это влияет на нагрузку оставшихся врачей и доступность помощи.

Обеспеченность койками , на 10 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Категория	2016	2024	Снижение
Койки для взрослых	7,60	6,63	-13%
Койки для детей	2,66	1,60	-40%

Ключевые наблюдения

- Обеспеченность койками снижается по обеим категориям.
- Детские койки сократились значительно сильнее (на 40%, взрослые — на 13%).
- Наиболее резкое снижение:
 - Взрослые: 2021 г. (7,08 → 6,6)
 - Дети: 2019 г. (2,48 → 1,64)
- Стабилизация с 2021–2022 гг. на минимальных значениях.

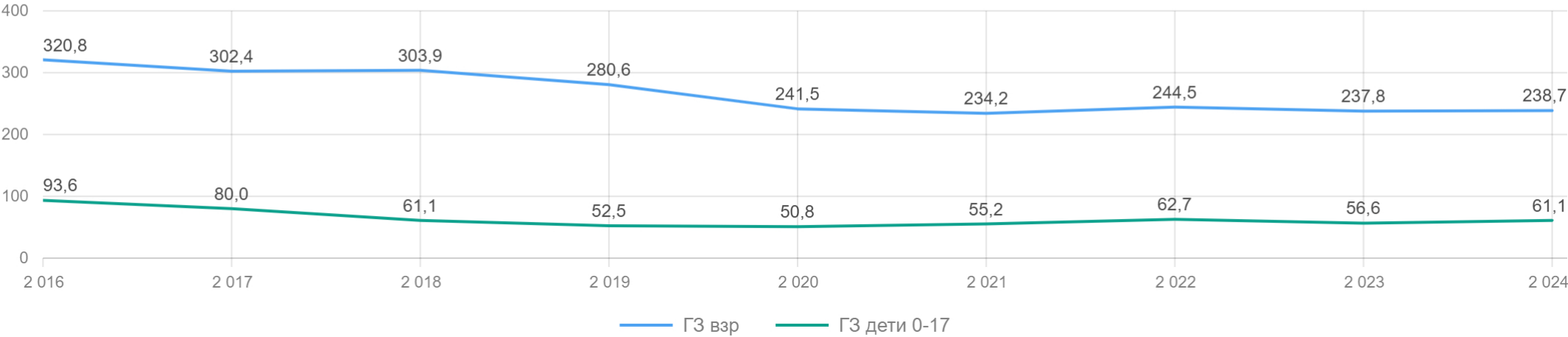
Вывод

Коечный фонд сокращается, особенно выраженно — детский (-40%). Это может отражать:

- реальное улучшение эпидситуации и снижение потребности в госпитализации,
- переход на амбулаторные формы лечения,
- либо оптимизацию ресурсов.

Для оценки адекватности сокращения необходимо сопоставить с динамикой заболеваемости и госпитализированной заболеваемости за те же годы.

ГЗ (взрослые и дети), на 100 т...



Ключевые выводы

Ключевые показатели

Категория	2016	2024	Снижение
Взрослые (18+)	320,78	238,69	-26%
Дети (0-17)	93,58	61,15	-35%

Ключевые наблюдения

- Оба показателя устойчиво снижаются за 9 лет.
- Детская заболеваемость снизилась сильнее (-35% vs -26% у взрослых).
- 2020 год — резкое снижение у обеих групп (вероятно, влияние пандемии).
- 2022 год — небольшой рост (взрослые: 234 → 244; дети: 55 → 63), после чего снижение возобновилось.

Вывод

Госпитализированная заболеваемость снижается во всех возрастных группах. Более выраженное снижение у детей (-35%) может свидетельствовать об эффективности профилактических мер. Стабилизация в последние годы требует мониторинга для предотвращения возможного роста.

ИТОГОВЫЙ ВЫВОД ПО ДАШБОРДУ

Положительные тенденции

1. **Заболеваемость, распространённость и смертность снизились в 3–6 раз** за 30 лет.
2. **ТБ+ВИЧ под контролем:** заболеваемость снизилась на 52–69%, смертность — на 93%.
3. **Эффективность лечения выросла:** клиническое излечение — с 41% до 80%.
4. **Охват госпитализацией достиг 93–97%.**
5. **Детская заболеваемость снизилась вдвое,** внелегочные формы — на 66%.

Проблемные зоны (требуют внимания)

1. **Первичная МЛУ растёт** (16% → 27%) — увеличение передачи устойчивых штаммов.
2. **Гендерный разрыв сохраняется** — мужчины болеют в 2,5 раза чаще.
3. **Кадровый дефицит:** укомплектованность физическими лицами — всего 60%, снижение общей укомплектованности с 95% до 86%.
4. **Кочный фонд сокращается** (детские койки — на 40%).
5. **2020 год** создал статистические артефакты — данные требуют осторожной интерпретации.

Рекомендации

1. **Усилить меры по снижению первичной МЛУ** (инфекционный контроль, раннее выявление).
2. **Сосредоточить профилактику на мужском населении** (целевые программы).
3. **Укрепить кадровый потенциал** (привлечение фтизиатров, снижение нагрузки).
4. **Мониторировать кочный фонд** в соответствии с реальной потребностью.
5. **Продолжить и расширить программы ранней диагностики** (особенно ФЛГ).

Общая оценка: эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в России и Иркутской области **значительно улучшилась** за последние 30 лет, особенно в последнее десятилетие. Система здравоохранения демонстрирует высокую эффективность лечения и госпитализации. Однако **растущая первичная МЛУ и кадровый дефицит** требуют оперативных управленческих решений.